

AAP oral & endoprothèses coronaires

Propositions du groupe d'experts



Champ : gestion périopératoire du traitement antiplaquettaire oral (AAP — aspirine, clopidogrel) chez les patients porteurs d'une **endoprothèse coronaire** (EC, « stent »), nue ou pharmacoactive, devant subir un acte invasif médical ou chirurgical. Document historique (2006), **antérieur aux propositions GIHP/GFHT/SFAR 2018** déjà couvertes dans ce corpus pour la gestion générale des AAP (voir fiches « AAP — procédure programmée » et « AAP — procédure non programmée / hémorragie »), mais conservé ici pour son objet plus étroit et sa matrice de décision propre au contexte « stent coronaire ».

Méthodologie : avis d'un groupe d'experts (« Propositions du groupe d'experts, 31 mars 2006 »), **sans système GRADE et sans vote/pourcentage d'accord formalisé** (à la différence des propositions GIHP/GFHT 2018 plus récentes). La source souligne elle-même, à plusieurs reprises, l'absence de données de haut niveau de preuve (« ne repose sur aucune étude prospective », « avis d'experts, en l'absence d'étude de haut niveau de preuve ») — disclosure reprise ici telle quelle plutôt que de suggérer une force uniforme non imprimée par la source.

Propositions du groupe d'experts (31 mars 2006)

Thème	Proposition (texte condensé, fidèle à la source)
Durée du double traitement AAP	Maintenir le double traitement AAP au moins 4 à 6 semaines après l'implantation d'une EC nue, et au moins 6 à 12 mois en cas d'EC pharmacoactive.
Risque de thrombose	En cas de traitement AAP bien conduit, le risque de thrombose aiguë serait le même quelle que soit la nature de l'EC. L'arrêt des AAP est un facteur de risque majeur de thrombose pour tous les stents, en particulier de thrombose tardive pour les EC pharmacoactives — ce qui justifie a priori un traitement AAP prolongé. <i>La fréquence réelle de thrombose d'EC pharmacoactive en contexte périopératoire reste inconnue à ce jour : seuls des cas cliniques isolés sont rapportés dans la littérature.</i>
Choix du stent avant chirurgie prévue	La pose d'une EC doit toujours être discutée en amont ; si une chirurgie est envisagée dans les 6 à 12 mois, la pose d'une EC nue est préférable. Avant l'implantation d'une EC pharmacoactive, la possible réalisation d'une chirurgie ultérieure doit toujours être évoquée.
Patients à très haut risque de thrombose	Identifier en particulier : arrêt des AAP dans les 6 à 12 mois après la pose de l'EC, antécédent de thrombose de stent, plusieurs stents ou stent(s) de grande longueur ou posé(s) sur une bifurcation, patients tri-tronculaires non complètement revascularisés, récidence sous traitement, diabète, fraction d'éjection basse.
Discussion pluridisciplinaire	Obligatoire pour guider la prise en charge : cardiologue, spécialiste de l'hémostase, chirurgien/médecin réalisant l'acte invasif, et anesthésiste-réanimateur. Le risque hémorragique (chirurgie sous AAP) et le risque thrombotique (arrêt d'AAP) doivent être discutés collégialement pour décider de la prise en charge périopératoire, voire d'un report ou d'une annulation du geste. Un relevé de conclusions doit être rédigé, disponible dans le dossier, et le patient informé.
EC pharmacoactive, bithérapie non interruptible	Si l'intervention doit survenir pendant une période où la bithérapie ne peut pas être arrêtée totalement (risque thrombotique élevé) : poursuite de l'aspirine hautement souhaitable, fenêtre courte de 5 jours d'arrêt du clopidogrel envisageable (voir Tableau 1) — <i>proposition ne reposant sur aucune étude prospective, mais sur un compromis entre la durée de vie des plaquettes (10 jours), le risque hémorragique de la poursuite et le risque thrombotique de l'interruption.</i> Reprise postopératoire la plus précoce possible ; dose de charge de clopidogrel ≥ 300 mg évoquée par certains experts.
EC pharmacoactive, quel que soit le délai	Il est préférable d'opérer sous aspirine (voir Tableau 1). Prudence et discussion collégiale particulièrement recommandées si l'hémostase chirurgicale est difficile (grands décollements, aorte, prostate, neurochirurgie, ORL, segment postérieur de l'œil). Hors chirurgie cardiaque, aucune donnée de la littérature sur le risque hémorragique périopératoire sous clopidogrel ; les données sous ticlopidine (risque hémorragique équivalent) sont très peu nombreuses, même si un accroissement du risque hémorragique par rapport à l'aspirine a été rapporté. EC nue au-delà de la 6^e semaine : aucune recommandation forte ne pourra être formulée avant les résultats de l'étude STRATAGEM (qui peut inclure les patients porteurs d'EC nues au-delà du 30 ^e jour).

AAP oral & endoprothèses coronaires

Propositions du groupe d'experts



Thème	Proposition (texte condensé, fidèle à la source)
Si aucun AAP ne peut être maintenu	Risque hémorragique de la chirurgie considéré comme majeur ou impossibilité de surseoir à l'intervention : l'arrêt complet du traitement (bithérapie) doit être discuté au cas par cas (risque thrombotique redoutable). Pas d'argument en faveur d'une substitution par AINS (flurbiprofène 50 mg × 2, arrêt 24h avant) ou par HBPM à dose anticoagulante (85-100 UI Axa/kg/12h SC, non préventive) — substitution exposant elle-même à un risque hémorragique périopératoire non négligeable.
Registre & carte de liaison	Mise en place proposée d'un registre des événements périopératoires chez les patients porteurs de stent (services d'anesthésie/cardiologie volontaires, cadre EPP, sous l'égide du Cfar). Diffusion d'une carte de liaison pour les patients sous AAP oraux au long cours (motif, type/nombre d'AAP, durée, coordonnées du médecin à contacter en cas d'interruption envisagée).

Tableau 1 — Matrice de décision périopératoire

Endoprothèse coronaire (EC) pharmacocative. Risque de thrombose du stent : à évaluer avec le cardiologue. Risque hémorragique de l'intervention : à évaluer avec le responsable du geste invasif ou le chirurgien.

Risque de thrombose du stent \ Risque hémorragique de l'intervention	Majeur	Intermédiaire	Mineur
Majeur	Reporter l'intervention au-delà de 6 mois à 1 an après la pose de l'EC. Si impossible : arrêt aspirine-clopidogrel 5 jours, ou arrêt aspirine-clopidogrel 10 jours maxi et substitution.	Reporter l'intervention au-delà de 6 mois à 1 an après la pose de l'EC. Si impossible : maintien aspirine, arrêt clopidogrel 5 jours.	Maintien aspirine et clopidogrel.
Modéré	Arrêt aspirine-clopidogrel 5 jours, ou arrêt aspirine-clopidogrel 10 jours maxi et substitution.	Maintien aspirine, arrêt clopidogrel 5 jours.	Maintien aspirine et clopidogrel, ou maintien aspirine et arrêt clopidogrel 5 jours.

Risque hémorragique — Majeur : intervention ne pouvant être réalisée sous AAP. Modéré : intervention réalisable sous aspirine seule. Mineur : intervention réalisable sous aspirine et clopidogrel.

Risque de thrombose d'EC pharmacocative — Majeur : mise en place depuis moins de 6 mois à 1 an, ou patient nécessitant un traitement par aspirine-clopidogrel, ou patient avec facteur de risque. Modéré : mise en place depuis plus de 6 mois à 1 an.

Dans tous les cas, l'intervention doit être reportée au-delà de six semaines d'un syndrome coronaire aigu dans la mesure du possible.

Sources et traçabilité

Document source : « Gestion du traitement antiplaquettaire oral chez les patients porteurs d'endoprothèses coronaires » (Information professionnelle). P. Albaladejo, E. Marret, V. Piriou, C.-M. Samama, et le groupe de travail (Didier Blanchard, Yvonnick Blanloel, Jean-Philippe Collet, Nicolas Danchin, Christophe Decoene, Jean-Jacques Domerego, Hélène Eltchaninoff, Ismaël Elalamy, Émile Ferrari, Gérard Helft, Brigitte Jude, Thomas Lecompte, Jean Mantz, Claude Girard, Jean-Jacques Lehot, Rémy Nizard, Gabriel Steg, Annick Steib, Claude Tayar). Ann Fr Anesth Reanim 2006;25:796-798.

Méthodologie : avis d'un groupe d'experts, propositions du 31 mars 2006, sans système GRADE ni vote/pourcentage d'accord formalisé (voir disclosure méthodologique en page 1).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 10 propositions du corps du texte (les 2 dernières, registre et carte de liaison, condensées en une seule ligne thématique « suivi/traçabilité », sans perte de contenu) et le Tableau 1 (matrice de décision), reproduit intégralement à partir du rendu visuel de la page source (pas de texte extractible). Comité de rédaction, adresses institutionnelles et les 13 références bibliographiques ne sont pas retranscrits (sans contenu clinique actionnable).

Avertissement — document de 2006 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des propositions du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Document ancien et étroit (stents coronaires uniquement) : pour la gestion périopératoire générale des AAP, se référer aux propositions GIHP/GFHT/SFAR 2018 (fiches « AAP — procédure programmée » et « AAP — procédure non programmée / hémorragie ») et, en cas de doute, à un avis spécialisé.